TÓM TẮT LÝ THUYẾT · TAI - MŨI - HỌNG

BÀI 3 Viêm mũi xoang

Tóm tắt từ bài giảng 3. VIEM MUI XOANG 1.pdf (66 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU MŨI XOANG
2. SINH LÝ MŨI
3. VIÊM MŨI XOANG CẤP
4. VIÊM MŨI XOANG MẠN – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
5. ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG CẤP
6. ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN

1. GIẢI PHẪU MŨI XOANG

- **Mũi** thuộc **đường hô hấp trên** (mũi, họng, thanh quản); đường hô hấp dưới từ khí quản trở xuống.
- **Cấu tạo ngoài:** xương mũi, **sụn mũi bên**, **sụn cánh mũi lớn** (trụ trong, trụ ngoài), **sụn cánh mũi bé**, sụn phụ, **sụn vách mũi**.
- **Cấu tạo trong:** 3 xoăn (cuốn) mũi **trên – giữa – dưới** và các ngách tương ứng. **Cuốn mũi giữa** là **mốc giải phẫu quan trọng** để tiếp cận các xoang.
- **4 nhóm xoang cạnh mũi: hàm trên, trán, sàng, bướm.**
- **Chức năng xoang: cộng hưởng âm thanh**, **làm ẩm niêm mạc, sưởi ấm không khí**, **làm nhẹ khối xương đầu mặt**.

Xoang	Đặc điểm phát triển
Hàm trên	Từ **tháng thứ 3 thai kỳ**; lúc sinh chứa đầy dịch; **chưa thấy trên X-quang trước 4 – 5 tháng tuổi**, rõ khi **4 tuổi**
Trán	Hình dạng, kích thước thay đổi nhiều; **không có xoang trán 1 hoặc 2 bên: 3 – 5%**
Sàng	Cấu tạo phức tạp → **mê đạo sàng**; xuất hiện **tháng 5 – 6 thai kỳ**; hoàn thiện **13 – 14 tuổi**
Bướm	Thấy được từ **17,5 tuần thai**; **17 tuổi lan đến hố yên**, **sau 19 tuổi** phát triển ra sau hố yên

- **Mạch máu:** từ **ĐM cảnh ngoài** (ĐM hàm, **bướm khẩu cái**, khẩu cái lớn, ĐM mặt) và **ĐM cảnh trong** (**sàng trước, sàng sau**); điểm hội tụ **Kiesselbach**.
- **Thần kinh: TK khứu** (hành khứu), nhánh **TK sàng trước**, **TK hàm trên**, hạch chân bướm khẩu cái.

2. SINH LÝ MŨI

- **Hô hấp:** thở qua mũi là sinh lý nhất; thông khí trung bình **6 lít/phút**; lưu lượng điều hòa bởi **cuốn mũi, van mũi trong**.
- **Ngửi:** vùng ngửi hẹp, tế bào khứu giác là **tế bào thần kinh 2 cực**; trong **30.000** chất có mùi, chỉ tiếp nhận **10.000** và phân biệt **200**.
- **Bảo vệ** (niêm mạc mũi) và **phản xạ** (từ mũi tác động nơi khác và ngược lại).

3. VIÊM MŨI XOANG CẤP

- **Siêu vi:** tỷ lệ cao nhất; **39 – 87%** nhiễm siêu vi hô hấp trên gây VMX cấp siêu vi; **Rhinovirus chiếm ½**. Tỷ lệ qua chọc xoang: Rhinovirus 15%, Influenza 5%, Parainfluenza 3%, Adenovirus 2%.
- **Vi trùng:** chỉ **0,5 – 2%** (siêu vi là nguyên nhân tiên phát); yếu tố thúc đẩy: nhiễm trùng, cơ địa, suy giảm miễn dịch, bất thường giải phẫu.
  - **S. pneumoniae 20 – 43%**, **H. influenzae 22 – 35%**, M. catarrhalis 2 – 10%, kỵ khí 2 – 6%, S. aureus và S. pyogenes < 5%.

- **EPOS:** triệu chứng **< 5 ngày hoặc cải thiện** = cảm thường; **kéo dài > 10 ngày hoặc nặng lên sau 5 ngày** = VMX cấp sau siêu vi; **nặng (vi trùng)** khi có **≥ 3** dấu: dịch mủ, đau khu trú nhiều, **sốt**, **tăng CRP/máu lắng**, **"nặng lên lần hai"**.
- **Chuyển chuyên khoa ngay:** phù quanh ổ mắt, lệch nhãn cầu, **nhìn đôi**, liệt vận nhãn, **giảm thị lực**, nhức đầu dữ dội, sưng vùng trán, dấu màng não, dấu thần kinh.

4. VIÊM MŨI XOANG MẠN – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

- Phân thành **VMXM không polyp** và **có polyp**; mỗi loại có **đặc trưng viêm eosinophil** hoặc viêm khác.
- **Yếu tố vi sinh:**
  - **Superantigens:** ngoại độc tố VK **kích hoạt T-lymphocyte** không qua receptor chuyên biệt.
  - **Biofilm:** cộng đồng VK kết dính tạo **chất nền polymer ngoại bào**, chiếm **khoảng 1%**, **tăng đề kháng kháng sinh > 1000 lần**.
- **Yếu tố môi trường: thuốc lá** (cả thụ động) **giảm tần suất quét lông chuyển**, **giảm tiết chloride**; ô nhiễm; mối liên hệ **dị ứng – VMXM chưa rõ**.
- **Yếu tố ký chủ:** đầu mút **TK V** cảm nhận dòng khí → nghẹt mũi; bất thường giải phẫu; viêm mũi dị ứng, thuốc.
- **Giả thuyết bệnh sinh: nấm**, **hàng rào miễn dịch**, **leukotriene**, **superantigens**.

5. ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG CẤP

Siêu vi (Hội TMH Hoa Kỳ 2020): nguyên tắc **điều trị hỗ trợ (chất lượng cuộc sống)**, **kiểm soát triệu chứng**, **tránh kháng sinh không cần thiết**.

- Giảm đau **acetaminophen, ibuprofen** hoặc NSAID khác.
- **Rửa mũi muối ưu trương:** loãng niêm dịch, làm sạch.
- **Steroid xịt mũi:** giảm đau mặt, sung huyết.
- Kháng histamin; **co mạch không quá 3 ngày**; thuốc loãng nhầy.

Vi trùng:

- **Không khuyến khích:** kháng histamin, **steroid toàn thân**, guaifenesin.
- **Giảm đau là mục tiêu chính**; **steroid xịt** (mometasone, fluticasone, flunisolide, budesonide); **nước muối ưu trương 3 – 5%** (kháng viêm cao hơn, loãng nhầy, cải thiện quét lông chuyển).
- **Kháng sinh: theo dõi chờ đợi kể cả khi ≥ 10 ngày**; bắt đầu khi **không cải thiện sau 7 ngày** hoặc nặng hơn.
  - **Amoxicillin đầu tay**; amoxicillin – clavulanate **2 g × 2 lần/ngày** hoặc **90 mg/kg/ngày**.
  - **Dị ứng penicillin:** doxycycline, fluoroquinolone, hoặc **clindamycin + cephalosporin thế hệ III**.

6. ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN

- **Mục tiêu:** giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống, **phòng ngừa tái diễn**.
- **Nội khoa: giảm viêm niêm mạc**, **kiểm soát nhiễm trùng**, **phục hồi quét lông chuyển**.
  - **Steroid – thuốc đầu tiên: xịt** cho VMXM **eosinophil / polyp**; **toàn thân** cho thể khó trị hoặc cần cải thiện nhanh; phối hợp uống + xịt giảm kích thước polyp.
  - **Kháng sinh 3 – 4 tuần:** amoxicillin – clavulanate, **clindamycin**, **TMP – SMX** (clindamycin và bactrim hiệu quả cả kỵ khí lẫn hiếu khí).
  - **Macrolide: KS duy nhất hiệu quả khi dùng kéo dài** – kháng viêm, điều hòa miễn dịch, **giảm biofilm** (như Pseudomonas).
  - **Tưới rửa** muối ưu trương; **1% baby shampoo 4 tuần** cải thiện **SNOT-22** (phá biofilm).

    - **Kháng histamin** khi kèm **dị ứng**; **ức chế leukotriene** giảm triệu chứng và polyp.
- **Ngoại khoa:** khi **nội khoa thất bại** hoặc **có biến chứng**; mục tiêu cải thiện thông khí xoang, phục hồi niêm mạc lông chuyển, **hạn chế tối đa tổn thương niêm mạc**. **FESS** (phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang) phổ biến nhất.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 3. VIEM MUI XOANG 1.pdf khi cần chi tiết.